ONEMA-POP-053 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Triagem de Suspeita de Infiltração, Extravasamento e Infecção de

Loja em Port-a-Cath

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de triagem de suspeita de infiltração, extravasamento

e infecção de loja em port-a-cath, em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade. Não substitui

prescrição, avaliação médica nem instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

EPIs, material de avaliação do sítio, termômetro, dispositivo de sinais vitais. Equipamentos profissionais/EPIs: enfermeiro

ONEMA; consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste contratual. Em visita presencial, equipamentos de

avaliação clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

Diferenciar infiltração/extravasamento de dor da loja, edema, rubor, calor, secreção e febre. Confirmar identificação,

consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Confirmar substância infundida, concentração, volume aproximado, tempo e acesso utilizado.

02. Suspender imediatamente a infusão diante de dor, edema ou suspeita de extravasamento.

03. Não realizar flush; manter dispositivo conforme protocolo específico da substância e orientação do serviço.

04. Avaliar extensão, pele, perfusão, dor, sinais sistêmicos e registrar fotografia apenas com consentimento.

05. Acionar imediatamente equipe prescritor/infusão para antídoto e manejo específico da substância quando aplicável.

06. Em febre, calafrios, secreção ou eritema da loja, suspeitar infecção e não utilizar acesso até avaliação.

07. Se necrose progressiva, síndrome compartimental, sepse ou instabilidade, encaminhar emergencialmente.

08. Documentar substância, cronologia, achados, medidas e destino.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Instabilidade, necrose, dor intensa progressiva, sinais de sepse: emergência. Na emergência, acionar SAMU 192 e registrar

o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Monitorar evolução e comunicar imediatamente piora local ou sistêmica.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento,

orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

CDC catheter guidelines; INS Infusion Therapy Standards (2024); protocolo de extravasamento específico do fármaco |

Conferir aplicação integral ao cenário brasileiro e IFU específico antes de liberação assistencial.

aplicativo.